

Protocolo de Manejo da Pneumonia Adquirida na Comunidade em Adultos

Hospital Cooperativo Serra Azul — Serra Azul (SC)

Identificador	PROT-006
Instituição	Hospital Cooperativo Serra Azul
Especialidade	pneumologia
Versão	1
Vigência	2025-12-01
Próxima revisão	2027-12-01
Responsável técnico	Comissão de Protocolos Assistenciais
Situação	VIGENTE

1. Objetivo

Padronizar a avaliação de gravidade e a definição do local de tratamento de pacientes adultos com pneumonia adquirida na comunidade.

2. Avaliação de gravidade

A avaliação de gravidade utiliza critérios clínicos objetivos aplicados na admissão e define o local de tratamento.

Critério	Presente
Confusão mental de início recente	1 ponto
Frequência respiratória igual ou superior a 30 por minuto	1 ponto
Pressão arterial sistólica abaixo de 90 mmHg	1 ponto
Idade igual ou superior a 65 anos	1 ponto

Pontuação	Local de tratamento sugerido
0 a 1	Tratamento ambulatorial com reavaliação em 48 a 72 horas
2	Internação em unidade de internação clínica
3 ou mais	Avaliação para internação em terapia intensiva

3. Esquema antimicrobiano empírico

A escolha do esquema empírico segue o mapa microbiológico institucional vigente, publicado semestralmente pela Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, e leva em conta o local de tratamento definido na seção 2, a presença de comorbidades e o uso de antimicrobiano nos noventa dias anteriores.

Este protocolo não define princípio ativo, dose nem duração. A prescrição é atribuição exclusiva do médico assistente, que deve consultar o mapa microbiológico vigente no momento do atendimento.

O início do antimicrobiano deve ocorrer dentro de quatro horas contadas a partir da confirmação diagnóstica.

4. Critérios de reavaliação

- Reavaliação clínica obrigatória em 48 a 72 horas do início do tratamento.

- Reavaliação imediata diante de piora dos sinais vitais.
- Revisão do esquema empírico à luz do resultado de culturas, quando colhidas.

5. Critérios de alta

- Estabilidade dos sinais vitais por no mínimo 24 horas.
- Capacidade de ingestão por via oral.
- Ausência de indicação de suporte de oxigênio.
- Orientação de retorno registrada em prontuário.

Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
1	2025-11-12	Versão inicial.

DOCUMENTO FICTÍCIO — gerado por software para demonstração técnica do projeto SCMedAI. Não é um protocolo clínico real, não foi validado por nenhuma instituição de saúde e **NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ORIENTAR CUIDADO A PACIENTES.**

FICTÍCIO